Penjelasan Akuntansi Setoran Pemilik, Kas Kecil, & Rekonsiliasi Laci Kasir

Klinik Pratama Cikidang Medika — Panduan & Penjelasan Resmi Manajemen Keuangan

Ditujukan Kepada: dr. Ade Sofyan (dr. Ovan) & Manajemen Klinik	**Tanggal Rilis:** 13 Oktober 2026
Fokus Analisis: Akuntansi Setoran Pemilik, Kas Kecil, & Laci Kasir	**Status Sistem: Selesai, Terverifikasi & Live di Produksi**

1. Ringkasan Eksekutif

Dokumen ini menyajikan penjelasan resmi atas **3 (tiga) penyempurnaan krusial** pada modul keuangan dan kasir SIM Klinik Pratama Cikidang Medika guna menanggapi masukan langsung dari **dr. Ade Sofyan**. Pembaruan ini memastikan bahwa setiap rupiah uang tunai di laci loket, belanja operasional harian, dan penyerahan kas ke pemilik tercatat dengan akuntabilitas 100% tanpa distorsi pada laporan laba rugi.

2. Poin 1: Perlakuan Akuntansi 'Setor ke Rekening Pemilik' (Rp 2.400.000 & Rp 50.000)

Pertanyaan dr. Ade Sofyan: *"Ini teh sudah masuk setor tunai ke pemilik, apakah bisa tidak dimasukkan ke pengeluaran, yang 2.400.000?"*

Akar Masalah: Pada 12 Oktober 2026, staf kasir mencatat **Rp 2.400.000** (keterangan *'stor tunai'*) dan **Rp 50.000** (keterangan *'amel tuker cash'*) melalui menu **Kas Keluar** → **Setor ke Rekening Pemilik**. Versi sistem terdahulu menjumlahkan seluruh transaksi berjenis *'Keluar'* ke pos **Pengeluaran Operasional & Obat**, sehingga beban operasional membengkak dari Rp 5.735.000 menjadi Rp 8.185.000 dan grafik harian 12 Oktober tampak seolah-olah mengalami **Defisit (-Rp 1.252.000)**.

Kaidah Akuntansi Medis: Penyerahan uang tunai laci kasir kepada pemilik klinik (dr. Ade Sofyan) adalah **perpindahan fisik aset kas** (dari laci kasir ke rekening/dompet pemilik), **BUKAN** beban biaya operasional klinik. Uang tersebut tidak berkurang/habis terpakai belanja.

Solusi Permanen yang Telah Diterapkan:
• Transaksi **Setor ke Rekening Pemilik** (serta **Setor Tunai**) otomatis **dikeluarkan dari beban pengeluaran operasional**.
• Beban pengeluaran operasional riil 1–12 Oktober kembali normal di angka **Rp 5.735.000** (murni obat, listrik, dan operasional).
• **Grafik Keuangan Harian (12 Okt):** Kas Masuk Rp 1.435.000 vs Kas Keluar Operasional Rp 237.000 → **Surplus +Rp 1.198.000** (grafik kembali hijau, tidak lagi defisit).
• Transaksi Rp 2.450.000 kini masuk ke kartu **Setor Tunai & Pemilik** dengan total akumulasi **Rp 6.865.000**.
• Di tabel Buku Kas, baris transaksi ini diberi badge khusus berwarna indigo/biru **"Setoran Laci ke Pemilik/Bank (Bukan Pengeluaran)"**.

3. Poin 2: Perbaikan Input Nominal Kas Kecil (< Rp 10.000 Tidak Lagi Terkalikan)

Pertanyaan dr. Ade Sofyan: *"Dan ini teh kas keluar gak bisa di bawah 10.000, kalau di bawah itu jadinya 1 juta."*

Akar Masalah: Saat migrasi data Google Sheets lama, terdapat fungsi otomatis yang mengalikan nilai < 10000 dengan 1.000 (karena file lama mencatat singkatan angka ribuan seperti 15 = 15.000 atau 150 = 150.000). Fungsi ini sebelumnya ikut terpanggil pada form kas keluar baru, sehingga ketika staf mengetik **1000** langsung berubah menjadi **Rp 1.000.000**, atau mengetik **5000** berubah menjadi **Rp 5.000.000**.

Solusi Permanen yang Telah Diterapkan:
• Perkalian otomatis pada formulir input baru telah **dinonaktifkan sepenuhnya**. Nominal berapapun yang diketik staf (seperti Rp 1.000, Rp 2.500, Rp 5.000) tersimpan **100% persis sesuai angka yang diketik**.
• Batas normalisasi data lama diturunkan hanya untuk angka di bawah 1.000 (< 1000), sehingga angka ribuan asli tidak pernah terkalikan.
• Disediakan tombol nominal instan kas kecil: **Rp 2.000, Rp 5.000, Rp 10.000, Rp 25.000, Rp 50.000, dan Rp 100.000** untuk mempercepat pencatatan staf kasir.

4. Poin 3: Mekanisme 4 Pilar Sisa Fisik di Laci Kasir (Rekonsiliasi Kasir)

Pertanyaan dr. Ade Sofyan: *"Yang ini ada pengeluaran, tapi tidak mempengaruhi sisa fisik di laci om, gimana caranya biar sesuai om?"*

Akar Masalah: Sebelumnya kartu Rekonsiliasi Kasir hanya menghitung Tunai Pasien - Setor Tunai tanpa memotong pengeluaran operasional tunai yang diambil langsung dari laci kasir (seperti Rp 10.000 gorengan dokter, Rp 213.000 token listrik & obat, atau Rp 14.000 kopi & biaya admin). Akibatnya angka sisa fisik laci di layar tidak berkurang saat uang kasir dipakai belanja.

Formula 4 Pilar Rekonsiliasi Laci Baru:
Setiap pengeluaran operasional tunai dan setoran pemilik kini **otomatis memotong sisa fisik laci kasir** secara seketika:

RUMUS BAKU FISIK LACI KASIR:
Sisa Fisik di Laci = ***Penerimaan Tunai Pasien Loket*** – ***Pengeluaran Tunai Laci (Operasional)*** – ***Disetor ke Pemilik/Bank***

Pilar Rekonsiliasi	Definisi Operasional	Arus Kas	Angka Riil (1–12 Okt 2026)

1. Tunai Masuk Laci	Pembayaran tunai pasien umum di loket kasir.	**+ Masuk Laci**	**+ Rp 18.895.000 (171 Pasien)**
2. Pengeluaran Tunai Laci	Belanja obat, token listrik, ATK, konsumsi dokter dari laci.	– **Keluar Laci**	– **Rp 5.735.000** (Beban Operasional)
3. Disetor ke Pemilik/Bank	Uang laci disetor ke bank atau diserahkan ke pemilik.	– **Keluar Laci**	– **Rp 6.865.000** (Setor Tunai & Pemilik)
4. Sisa Fisik di Laci Kasir	**Uang cash fisik yang wajib ada di dalam laci saat ini.**	**= Saldo Laci**	**Rp 6.295.000 (Tersisa di Laci Loket)**

5. Bukti Keseimbangan & Konservasi Kas Riil Klinik

Berikut adalah pembuktian matematis bahwa seluruh uang klinik terkunci sempurna sampai ke rupiah terakhir:
• **Sisa Fisik di Laci Kasir:** Rp 6.295.000
• **Dana di Rekening Bank & Pemilik:** Rp 7.500.000 *(Transfer Pasien Rp 635.000 + Setoran Kasir Rp 6.865.000)*
• **Total Saldo Kas Bersih Klinik:** Rp 6.295.000 + Rp 7.500.000 = **Rp 13.795.000**
Angka ini **cocok 100%** dengan kalkulasi laba bersih pada Dashboard Eksekutif:
Omzet Pasien Umum (Rp 19.530.000) – Pengeluaran Operasional (Rp 5.735.000) = **Rp 13.795.000**

6. Panduan Praktis Alur Pencatatan untuk Staf Kasir

Kebutuhan Transaksi	Menu	Jenis	Kategori yang Dipilih	Pengaruh ke Sistem
Beli obat darurat, BHP, reagen	**+ Kas Keluar**	Keluar	Pengeluaran Obat / Operasional	Memotong uang laci & masuk beban obat.
Token PLN, WiFi, PDAM	**+ Kas Keluar**	Keluar	Operasional & Listrik/Air	Memotong uang laci & masuk beban operasional.
Konsumsi dokter, makan, ATK	**+ Kas Keluar**	Keluar	Pengeluaran Non Klinik	Memotong uang laci & masuk beban operasional.
Serah uang laci ke dr. Ade Sofyan	**+ Kas Keluar**	**Keluar**	**Setor ke Rekening Pemilik**	**Memotong uang laci, TIDAK memotong laba klinik.**
Setor uang laci ke bank klinik	+ Kas Masuk/Keluar	Keluar/Masuk	Setor Tunai	Memotong uang laci, menambah saldo bank klinik.

7. Kesimpulan & Komitmen Kualitas

Dengan berlakunya pembaruan ini, seluruh pencatatan arus kas dan rekonsiliasi kasir Klinik Pratama Cikidang Medika berjalan dengan prinsip akuntansi yang sehat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kapan saja. Seluruh perbaikan telah lulus uji verifikasi otomatis dan langsung aktif pada sistem yang sedang berjalan.

Disiapkan Oleh: **Tim Pengembang SIM Klinik** Sistem Informasi Cikidang Medika	Diverifikasi & Diketahui Oleh: **dr. Ade Sofyan (dr. Ovan)** Direktur Klinis / Pimpinan Klinik